

SPECIJALISTIČKI PREGLED

Protokol broj: **2026002174**

MULALIĆ NEDŽAD

Rođen: 20.06.1933, Adresa: PLETENCI 4/1, 51000 RIJEKA

Dijagnoza: N30 - Upala mokraćnog mjehura (cistitis)

MBOO: 119931965

Datum pregleda: 31.07.2026

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA
Objednjava hitni bolnički prijem
Lokalitet Rijeka, Krešimirova 42, 51000 Rijeka
Tel. 051/658-101, Fax. 001/658-647

Anamneza i razlog dolaska Bolesnik je upućen na pregled dežurne internističke službe zbog tjelesnog propadanja

Bolesnik ima proljevaste stolice unazad više mjeseci do 4-5 dnevno. Jucer je bio febrilan do 37,5°C bez zimica i tresavica uz intermitentne bolove u abdomenu.

U prilogu i nalaz u kojem se navodi CEA>1000; C19-9 <1.5; na MR-u 29.3.2025. znakovi peritonealne karcinomatize. Bez mučnine i povraćanje. Nije imao vrtoglavice, omaglice, krize svijesti. Bez boli u prsima, palpitacija ili dispneje.

Apetit varira uz recentne gubitke na TT. Izgubio je oko 15-ak kilograma unutar zadnjih nekoliko mjeseci. Mokrenje bez dizuricnih tegoba, urin koncentriran. Stolica proljevasta, bez patoloških primjesa.

Alkohol ne konzumira, ne puši.

Dosadašnje bolesti: stanje nakon kompresivne frakture L4 uz osteosintezu pločicom i vijcima (LCP - VA); stanje nakon fiksacije kralješka L3/L5, arterijska hipertenzija, hiperplazija prostate

Kronična th: Proscar, Massido

Alergije na lijekove do sada nije manifestirao.

Nalaz Zadovoljavajućeg općeg stanja, orijentiran u sva tri pravca, pokretan. Klinički kardijalno kompenziran, hemodinamski stabilan. Koža i vidljive sluznice uredno prokrvljeni. Turgor primjeren dobi.

Glava b.o.

Vratne vene prazne, trahea medioponirana.

Srčana akcija ritmična, tonovi jasni, šumova ne čujem.

Nad plućima obostrano uredan disajni šum.

Abdomen u razini prsnog koša, mekan i bezbolan pri palpaciji, peristaltiku ne čujem sa sigurnošću. LS negativna, organomegalije ne palpiram.

Ekstremiteti simetrični, bez edema, palpabilnih pulzacija na sva 4 ekstremiteta.

Postupci EKG: srednja el. os, SR fr. 120/min

ABS (venska krv) - pH - ak 7.49, pCO₂ - ak 4.8 kPa, pO₂ - ak 3.6 kPa, Akt.HCO₃-a 26.7 mmol/L, tCO₂ - ak 27.8 mmol/L, SBE - ak 3.7 mmol/L, sO₂ - ak 45.5 %, tHb POCT 105 g/L, Hct POCT 0.324 L/L, MetHb - ak 1.0 %, COHb - ak 1.2 %, Ohb - ak 44.5 %, GUK - ak 9.3 mmol/L, Na - ak 134 mmol/L, K - ak 2.8 mmol/L, Cl - ak 110 mmol/L, Ca++ - ak 1.05 mmol/L, Lact - ak 4.4 mmol/L

Lab: E 3.56 [1e12]/L, Hgb 101 g/L, Hct 0.314 L/L, MCV 88.2 fL, MCH 28.4 pg, MCHC 322 g/L, RDW 16.3 %, Trc 186 [1e9]/L, MPV 9.3 fL, Lkc 13.4 [1e9]/L, GLU (s) 8.9 mmol/L, UREJA 13.4 mmol/L, KREA 120 µmol/L, eGFR CKD 45 mL/min/1.73m², Na 140 mmol/L, K (s) 3.0 mmol/L, Cl 102 mmol/L, TBIL 14 µmol/L, BIL-K 4 µmol/L, BIL -NK 10 µmol/L, AST 40 U/L, ALT 15 U/L, ALP 140 U/L, GGT 12 U/L, AMY 37 U/L, LIP 33 U/L, CRP 148.8 mg/L, Izgled (u) / / , Boja (u) / / , Specifična težina / kg/L, pH (u) / pH j., Leukocitna ester / / , Proteini (u) / / , Glu-urin / / , Ketoni / / , Urobilinogen (u) / / , Nitriti (u) / / , Bilirubin (u) / / , Eritrociti/hemog / / , Sed. /

TnI; NT-proBNP: TnI 25.1 ng/L, NTproBNP 3600 ng/L

URIN: Izgled (u) Mutan / , Boja (u) Tamno žut / , Specifična težina 1.015 kg/L, pH (u) 5.0 pH j., Leukocitna ester +++ / , Proteini (u) neg / , Glu-urin norm / , Ketoni neg / , Urobilinogen (u) norm / , Nitriti (u) neg / , Bilirubin (u) neg / , Eritrociti/hemog + / , Eritrociti 4 [1e6]/L, Leukociti (u) 4069 [1e6]/L, Bakterije (u) 4462 [1e6]/L

Koagulogram: PV 0.93 udio, INR 1.0, APTV 18.8 s, APTV-om 0.7, Fib 2.9 g/L

AP RADIOGRAM GRUDNIH ORGANA

U projekciji lijevog plućnog krila vidi se opsežniji areal inhomogenog zasjenjenja vjerojatno upalne etiologije.

Moguć je i razliveni lijevostrani pleuralni izljev.

RADIOGRAM ABDOMENA LEŽEĆI NA LIJEVOM BOKU

Meteorizam vijuga uz crijevni sadržaj i poneki kraći aerolikvidni nivo.

Bez znakova za pneumoperitoneum.

UZV trbuha: u jetri sekundarizam, moguće i više njih, bez ascitesa, tvorba i desnog bubrega i.o.

Konzilijarni - Prof.dr.sc. Karmen Lončarek -- 31.07.2026

Anamneza i razlog dolaska Na uputnicu, radi uključivanja u palijativnu skrb. Gospodin Mulalić boluje od proširene maligne bolesti (karcinomatoza peritoneuma, nepoznato sjelo primarnog tumora), lošeg općeg stanja. Živi s dementnom suprugom.

Postupci Pacijentu se prema kriterijima SPICT dodjeljuje šifra Z51.5, te se uključuje u bolnički registar palijative i aplikaciju za županijsku palijativu CISPAL.

Dijagnoza:

Z51.5 Palijativna skrb

C76 Zloćudna novotvorina ostalih i nedovoljno definiranih sijela

C78.6 Sekundarna zloćudna novotvorina retroperitoneja i peritoneja

Preporuka Dg. Proširena maligna bolest probavnog trakta vs, Urinarna infekcija/Lijevostrana pneumonija i.o.

U bolesnika se izvjesno radi o proširenoj malignoj bolesti (sindrom dijareje, tjel. propadanje, metastaze jetre, karcinomatoza peritoneuma, CEA tumorski marker>1000). Obzriom na visoku životnu dob, ne nalazim svrhe invazivno obrađivati sjelo tumora, uostalom i da se dokaže patohistološka dijagnoza, ne vidim cilj u onkološkom liječenjem, a pritom i sam pacijent nije navedenom sklon, želi kući. Razgovarano sa sinom.

Dodijeljena je šifra palijativne skrbi.

Potrebno je osigurati najbolju moguću potpurnu i palijativnu skrb, putem palijativnog tima i njege u kući ili smještaj u Hospicij Marija K Kozulić, a isto ide putem sektorskog liječnika na temelju ovog nalaza.

Nastaviti antibiotik po infektologu (prvu dozu dobio u OHBP-u), a uvesti za bolove Durogesic 50 mcg transdermalni flaster uz zamjene svakih 72 h + Tramadol 20 kapi per os dodatno po potrebi za kupiranje bolova, Seldiar 2x po jednu ili 2 caps zbog dijarejalnog sindroma.

Furosemid svaki 2. ili 3. dan uz Kalinor eff, a Prosure 2 pak dnevno (lagano piti kroz dan da ne provociraju naglo stolicu) za SARC F>4.

Paracetamol 500 mg dnevno po potrebi (max dnevna doza je 4x1000 mg) u slučaju febriliteta.

Naputak: pzz - Javiti se odabranom liječniku obiteljske medicine

Liječnik (Specijalizant):	Liječnik:
Ivan Radaković, dr.med.	Virna Medanić, dr.med.
Specijalizant kardiologije	Spec.opće interne medicine
(9097864)	(7995318)

Datum izdavanja: 31.07.2026. 13:00

NAPOMENA: Umjesto propisanog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jednakim dozama.

Sadržaj ispisa medicinske dokumentacije, potpisi i titule liječnika istovjetni su sadržaju na dan izrade dokumentacije. Zaglavlje dokumenta sadrži podatke o sistematizaciji organizacijskih jedinica i nositeljima funkcija na dan ispisa dokumenta.